

Pneumonia comunitária · pediátrica

PAC na criança é diagnóstico clínico-radiológico. Idade orienta etiologia e antibiótico; taquipneia, tiragem e SatO₂, baixa definem gravidade e internação.

Etiologia por idade (visão clássica)

Lembre - Etiologia por idade (visão clássica)

Neonato: GBS, enterobactérias, Listeria. Lactente/pré-escolar: vírus + pneumococo. Escolar/adolescente: pneumococo e atípicos (Mycoplasma).

Triagem: SatO₂, esforço respiratório e capacidade de se alimentar decidem o nível de cuidado.

PAC pediátrica - gravidade

Ambulatorial / enfermaria / UTI

Ambulatorial

Bom estado geral
SatO₂ adequada
Aceita VO / ATB VO

Retorno precoce

Enfermaria

Tiragem / taquipneia
SatO₂ baixa
ATB EV +/- O₂

Monitorar

UTI

Distress grave
Apneia / cianose
Choque / falha ventilatória

Suporte avançado

Antibiótico empírico (ideia R1)

- Amoxicilina VO é 1ª linha na PAC bacteriana não complicada em ambulatorial
- Penicilina/ampicilina EV em internados sem complicação (conforme protocolo)
- Associar cobertura atípica quando clínica compatível no escolar
- Neonato e toxemia: esquema amplo + investigar sepse

Internação — critérios frequentes

Critério | Exemplo

Hipoxemia | SatO₂ < 92% em ar ambiente

Esforço | Tiragem subcostal, gemido, batimento de asa

Ingestão | Recusa / desidratação

Social / falha | Vômitos de ATB, dúvida de adesão

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Sibilância isolada em lactente sugere mais bronquiolite/viral do que 'pneumonia bacteriana típica'. Não automatize ATB sem critérios de gravidade/focalidade.